BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGOẠI CHẤN THƯƠNG

Bản cập nhật để trình thẩm định ngày 14/10/2026. Gồm 15 quy trình, cấu trúc 5 bước chăm sóc; chưa ban hành.

Biên soạn: …… Thẩm định: …… Phê duyệt: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……

Phạm vi và nguyên tắc

Đây là quy trình chăm sóc bệnh lý: nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Không ép theo đề cương QĐ3023. Khi chăm sóc có kỹ thuật thay băng, cắt lọc, bó bột, nắn, chọc hút hoặc can thiệp khác, sử dụng quy trình kỹ thuật riêng theo QĐ3023 và hướng dẫn chuyên môn tương ứng.

Giữ nội dung phù hợp của bản nguồn; các thay đổi tập trung an toàn và khả năng thực hiện. Những tên tài liệu tham khảo chung chưa rõ số hiệu/ấn bản trong nguồn không được coi là đã xác minh; cuối mỗi quy trình ghi nguồn đối chiếu cụ thể. Hướng dẫn quốc tế hỗ trợ rà soát theo đối tượng, không thay thế quy định Việt Nam hoặc y lệnh.

Chẩn đoán/vấn đề trong bộ là gợi ý: chọn theo dữ liệu thực tế, tách vấn đề hiện có khỏi nguy cơ. Bác sĩ xác định bệnh, chỉ định điều trị và kỹ thuật; điều dưỡng thực hiện theo phạm vi, năng lực và phân công, không tự quyết định phẫu thuật, bổ sung thuốc hoặc thay kế hoạch hồi sức.

Danh mục

CS-NCT-01. VẾT THƯƠNG NHIỄM TRÙNG

CS-NCT-02. SAU BÓ BỘT CHI TRÊN Ở TRẺ EM

CS-NCT-03. SAU BÓ BỘT CHI DƯỚI Ở TRẺ EM

CS-NCT-04. SAU MỔ KẾT HỢP XƯƠNG CHI TRÊN Ở TRẺ EM

CS-NCT-05. SAU MỔ KẾT HỢP XƯƠNG CHI DƯỚI Ở TRẺ EM

CS-NCT-06. VẾT THƯƠNG BỎNG NHIỆT

CS-NCT-07. VẾT THƯƠNG BỎNG NHIỆT Ở TRẺ EM

CS-NCT-08. NGƯỜI BỆNH LIỆT THẦN KINH QUAY MUỘN DO CHẤN THƯƠNG

CS-NCT-09. NGƯỜI BỆNH TỤ DỊCH DƯỚI DA SAU CHẤN THƯƠNG

CS-NCT-10. NGƯỜI BỆNH THOÁI HOÁ CỘT SỐNG

CS-NCT-11. NGƯỜI BỆNH TRẬT KHỚP

CS-NCT-12. NGƯỜI BỆNH HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY

CS-NCT-13. NGƯỜI BỆNH NGÓN TAY CÒ SÚNG

CS-NCT-14. NGƯỜI BỆNH CHẤN ĐỘNG NÃO DO CHẤN THƯƠNG

CS-NCT-15. NGƯỜI BỆNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO CÓ TỔN THƯƠNG Ổ NÃO

CS-NCT-01. QUY TRÌNH CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG NHIỄM TRÙNG

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Thời điểm xuất hiện vết thương, nguyên nhân (phẫu thuật, tai nạn, loét tì đè, đái tháo đường…)

Quá trình tiến triển: đau, sưng, nóng, đỏ, chảy dịch, mùi hôi

Tiền sử:

Bệnh mạn tính: đái tháo đường, suy thận, suy gan, suy giảm miễn dịch

Dị ứng thuốc (đặc biệt kháng sinh, dung dịch sát khuẩn)

Tiền sử nhiễm trùng vết thương trước đó

Thuốc đang sử dụng: kháng sinh, corticoid, thuốc ức chế miễn dịch

1.2. Khám thực thể

Toàn thân:

Dấu hiệu sinh tồn: nhiệt độ, mạch, huyết áp, nhịp thở

Dấu hiệu nhiễm trùng toàn thân: sốt, mệt mỏi, rét run

Tại chỗ vết thương:

Vị trí, kích thước, độ sâu

Dấu hiệu nhiễm trùng: đỏ, sưng, nóng, đau

Dịch tiết: số lượng, màu sắc, mùi

Tình trạng mô: hoại tử, giả mạc, mô hạt

Da xung quanh vết thương

1.3. Cận lâm sàng (nếu có)

Công thức máu (bạch cầu tăng)

CRP, Procalcitonin

Cấy dịch vết thương và kháng sinh đồ

Đường huyết (đặc biệt bệnh nhân đái tháo đường)

Các xét nghiệm khác theo chỉ định bác sĩ

1.4. Khám các hệ thống cơ thể liên quan

Hô hấp: dấu hiệu nhiễm trùng lan tỏa

Tuần hoàn: tưới máu ngoại vi, phù nề

Tiết niệu – nội tiết: kiểm soát đường huyết

Dinh dưỡng: cân nặng, BMI, dấu hiệu suy dinh dưỡng

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Nhiễm trùng lan rộng

Nhiễm khuẩn huyết

Hoại tử mô, chậm liền vết thương

Cắt cụt chi (trong các trường hợp nặng)

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Đau tăng

Sốt kéo dài

Chảy mủ nhiều, mùi hôi

Giảm vận động vùng tổn thương

2.3. Nguy cơ liên quan bệnh nền

Đái tháo đường → chậm lành vết thương

Suy giảm miễn dịch → nhiễm trùng kéo dài

Suy dinh dưỡng → giảm tái tạo mô

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chăm sóc chung

Kiểm soát nhiễm trùng vết thương

Thúc đẩy quá trình lành vết thương

Phòng ngừa biến chứng

Nâng cao kiến thức và tuân thủ điều trị của người bệnh

3.2. Mục tiêu cụ thể

Vết thương giảm sưng, đỏ, đau

Dịch tiết giảm, không mùi

Không xuất hiện biến chứng nhiễm trùng

Người bệnh hiểu và thực hiện đúng chăm sóc vết thương

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Chăm sóc vết thương

Thực hiện vô khuẩn khi thay băng

Rửa vết thương bằng dung dịch phù hợp theo y lệnh (NaCl 0,9%, dung dịch sát khuẩn được phép)

Loại bỏ mô hoại tử do người đủ phạm vi và năng lực thực hiện theo chỉ định/quy trình kỹ thuật riêng; điều dưỡng chuẩn bị, hỗ trợ và theo dõi, không tự cắt lọc ngoài phân công.

Thay băng đúng kỹ thuật, đúng tần suất

Theo dõi và ghi nhận diễn biến vết thương hàng ngày

4.2. Thực hiện y lệnh

Dùng kháng sinh đúng loại, đúng liều, đúng giờ

Theo dõi tác dụng phụ của thuốc

Hỗ trợ các thủ thuật nếu có

4.3. Dinh dưỡng

Đánh giá nhu cầu dinh dưỡng, đủ năng lượng và đạm phù hợp bệnh nền; vitamin/kẽm theo khẩu phần hoặc chỉ định khi có thiếu/nguy cơ, không bổ sung liều cao thường quy.

Kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường

Đảm bảo đủ nước

4.4. Vệ sinh – chăm sóc toàn thân

Giữ da xung quanh vết thương sạch, khô

Hỗ trợ vệ sinh cá nhân

Thay đổi tư thế (nếu nằm lâu)

4.5. Giáo dục sức khỏe

Hướng dẫn người bệnh nhận biết dấu hiệu nhiễm trùng nặng

Cách giữ vệ sinh vết thương tại nhà

Tuân thủ dùng thuốc và tái khám

Không tự ý bôi thuốc, đắp lá lên vết thương

5. Đánh giá

Tình trạng vết thương

Dấu hiệu sinh tồn

Mức độ đau

So sánh với mục tiêu đề ra

Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc khi cần

Ghi chép đầy đủ hồ sơ điều dưỡng

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Khó thở, giảm ý thức, chảy máu nhiều, dấu giảm tưới máu, đau vượt dự kiến, sốt kèm xấu đi hoặc yếu/tê mới: báo bác sĩ, đánh giá và hỗ trợ cấp cứu theo tình trạng. Không chỉ tăng thuốc giảm đau để che dấu diễn biến.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

NICE NG125 Nhiễm trùng vết mổ: https://www.nice.org.uk/guidance/ng125/chapter/recommendations

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-02. QUY TRÌNH CHĂM SÓC SAU BÓ BỘT CHI TRÊN Ở TRẺ EM

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Tuổi, giới

Nguyên nhân bó bột: gãy xương, trật khớp, chấn thương phần mềm

Thời điểm bó bột, loại bột (bột thường, bột sợi thủy tinh)

Tiền sử:

Dị ứng (thuốc, bột bó)

Bệnh lý kèm theo: rối loạn đông máu, bệnh tim, hen, động kinh

Tiền sử chấn thương hoặc bó bột trước đó

1.2. Nhận định toàn trạng

Dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, nhịp thở

Tình trạng tinh thần:

Trẻ tỉnh táo, quấy khóc, lo lắng

Khả năng hợp tác theo lứa tuổi

Mức độ đau (theo thang điểm phù hợp với trẻ)

1.3. Nhận định chi bó bột

Màu sắc da đầu chi: hồng, tái, tím

Nhiệt độ đầu chi: ấm hay lạnh

Phù nề: có/không, mức độ

Cảm giác: tê bì, giảm cảm giác

Vận động: cử động được các ngón tay

Tuần hoàn: thời gian hồi máu mao mạch

Tình trạng bột:

Khô, nứt, chặt/lỏng

Có mùi, ẩm, bẩn không

Da quanh mép bột: trầy xước, loét

1.4. Cận lâm sàng (nếu có)

X-quang kiểm tra sau bó bột

Các xét nghiệm khác theo chỉ định bác sĩ

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Hội chứng chèn ép khoang

Rối loạn tuần hoàn – thần kinh ngoại vi

Phù nề tăng gây chèn ép

Loét da do bột bó

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Đau tăng

Tê bì, giảm vận động các ngón tay

Quấy khóc, khó chịu do bột chật

2.3. Nguy cơ liên quan

Trẻ hiếu động làm ướt, va đập bột

Cha mẹ thiếu kiến thức chăm sóc

Không tuân thủ tái khám

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chung

Đảm bảo tuần hoàn, cảm giác và vận động chi bó bột

Giảm đau, phòng ngừa biến chứng

Giữ bột khô, sạch, đúng tư thế

Gia đình hiểu và thực hiện đúng chăm sóc tại nhà

3.2. Mục tiêu cụ thể

Chi bó bột không sưng nề, không tím tái

Trẻ giảm đau, sinh hoạt phù hợp

Không xuất hiện dấu hiệu chèn ép khoang

Cha mẹ nhận biết được dấu hiệu nguy hiểm

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Theo dõi chi bó bột

Kiểm tra tuần hoàn – vận động – cảm giác:

Theo dõi tuần hoàn, cảm giác, vận động và đau bằng thang phù hợp tuổi; ghi so sánh với ban đầu/chi lành. Sau bó bột, chấn thương hoặc mổ chi: kế hoạch theo dõi cá thể do bác sĩ/khoa xác nhận; tham khảo RCH ở trẻ em: mỗi giờ trong 24 giờ đầu, sau đó mỗi 4 giờ trong 48 giờ tiếp theo nếu ổn định, tăng tần suất khi bất thường. Không dùng lịch này thay theo dõi hồi tỉnh sau gây mê.

Ghi thời điểm, người nhận định và diễn biến; đánh giá ngay khi trẻ đau tăng/quấy bất thường, không chờ đến lượt theo dõi.

So sánh với chi lành

Báo bác sĩ ngay nếu:

Đau tăng nhiều, không đáp ứng thuốc

Tím tái, lạnh đầu chi

Tê bì, mất vận động

4.2. Giảm đau – tư thế

Nâng đỡ chi theo chỉ định và tình trạng tưới máu. Nếu nghi tổn thương mạch hoặc chèn ép khoang, giữ chi không cao hơn mức tim, báo bác sĩ ngay; không kê cao quá mức hoặc chỉ chờ đáp ứng thuốc giảm đau.

Hướng dẫn trẻ cử động các ngón tay nhẹ nhàng

Thực hiện y lệnh thuốc giảm đau

Trấn an, dỗ dành trẻ

4.3. Chăm sóc bột bó

Giữ bột khô, sạch

Không cho trẻ:

Nhét đồ vật vào trong bột

Làm ướt hoặc đập bột

Kiểm tra mép bột và da, xử lý vùng cọ xát theo quy trình; không nhét thêm bông/vật vào dưới bột làm tăng chèn ép.

Không tự ý cắt, nới bột

4.4. Dinh dưỡng – sinh hoạt

Chế độ ăn đầy đủ năng lượng, canxi, vitamin D

Khuyến khích uống đủ nước

Hướng dẫn sinh hoạt phù hợp, tránh vận động mạnh

4.5. Giáo dục sức khỏe cho gia đình

Hướng dẫn theo dõi tại nhà:

Đau tăng

Sưng nhiều

Tím tái, lạnh, tê

Nhắc tái khám đúng hẹn

Giải thích thời gian mang bột và chăm sóc sau tháo bột

5. Đánh giá

Tình trạng tuần hoàn, cảm giác, vận động chi bó bột

Mức độ đau của trẻ

Tình trạng bột và da xung quanh

Mức độ hiểu và hợp tác của gia đình

Ghi chép đầy đủ hồ sơ điều dưỡng

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau vượt dự kiến hoặc tăng dù đã giảm đau, đau khi vận động thụ động phù hợp đánh giá, tê/yếu mới, chi căng hoặc tưới máu giảm: dừng thao tác, báo bác sĩ khẩn, đánh giá lại mạch–thần kinh. Mạch còn không loại trừ chèn ép khoang; không chờ đủ 5P. Giữ chi không cao hơn mức tim khi nghi giảm tưới máu; nới băng/bột chỉ do người được phép theo quy trình/chỉ định, ghi diễn biến.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

RCH Neurovascular observations: https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Neurovascular_observations/

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-03. QUY TRÌNH CHĂM SÓC SAU BÓ BỘT CHI DƯỚI Ở TRẺ EM

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Tuổi, giới

Nguyên nhân bó bột: gãy xương đùi, cẳng chân, cổ chân; trật khớp

Thời điểm bó bột, loại bột

Tiền sử:

Dị ứng thuốc, dị ứng bột

Bệnh lý kèm theo (tim bẩm sinh, rối loạn đông máu…)

Tiền sử chấn thương, bó bột trước đó

1.2. Nhận định toàn trạng

Dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, nhịp thở

Tình trạng tinh thần: tỉnh táo, quấy khóc, lo lắng

Đánh giá đau theo thang điểm phù hợp với lứa tuổi

Khả năng hợp tác của trẻ

1.3. Nhận định chi bó bột

Màu sắc da đầu chi: hồng, nhợt, tím

Nhiệt độ đầu chi: ấm hay lạnh

Phù nề: mức độ, diễn tiến

Cảm giác: tê bì, giảm/mất cảm giác

Vận động:

Cử động được các ngón chân

Tuần hoàn:

Mạch mu chân/chày sau (nếu sờ được)

Thời gian hồi máu mao mạch

Tình trạng bột:

Khô, chắc, nứt, lỏng

Có mùi, ẩm, bẩn

Da vùng mép bột: trầy xước, loét

1.4. Cận lâm sàng (nếu có)

X-quang kiểm tra sau bó bột

Các xét nghiệm theo chỉ định bác sĩ

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Hội chứng chèn ép khoang

Rối loạn tuần hoàn – thần kinh chi dưới

Phù nề tăng gây chèn ép bột

Loét da, viêm da do bột

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Đau tăng

Tê bì, lạnh, tím đầu chi

Hạn chế vận động

2.3. Nguy cơ liên quan

Trẻ hiếu động làm bột ướt, nứt

Ngã, va chạm khi tập đi/nằm

Gia đình thiếu kiến thức chăm sóc tại nhà

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chung

Đảm bảo tuần hoàn, cảm giác và vận động chi bó bột

Giảm đau, phòng biến chứng

Giữ bột khô, sạch, đúng tư thế

Gia đình thực hiện đúng chăm sóc và theo dõi tại nhà

3.2. Mục tiêu cụ thể

Chi bó bột không sưng nề tăng, không tím tái

Trẻ giảm đau, sinh hoạt phù hợp

Không xảy ra biến chứng chèn ép khoang

Cha mẹ nhận biết được dấu hiệu cần tái khám ngay

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Theo dõi chi bó bột

Kiểm tra tuần hoàn – vận động – cảm giác:

Theo dõi tuần hoàn, cảm giác, vận động và đau bằng thang phù hợp tuổi; ghi so sánh với ban đầu/chi lành. Sau bó bột, chấn thương hoặc mổ chi: kế hoạch theo dõi cá thể do bác sĩ/khoa xác nhận; tham khảo RCH ở trẻ em: mỗi giờ trong 24 giờ đầu, sau đó mỗi 4 giờ trong 48 giờ tiếp theo nếu ổn định, tăng tần suất khi bất thường. Không dùng lịch này thay theo dõi hồi tỉnh sau gây mê.

Đánh giá ngay khi có thay đổi, ghi thời điểm và báo bác sĩ bất thường.

So sánh với chi lành

Báo bác sĩ ngay khi:

Đau tăng nhiều, không giảm dù đã dùng thuốc

Ngón chân tím tái, lạnh

Tê bì, giảm/mất vận động

4.2. Tư thế – giảm đau

Nâng đỡ chi theo chỉ định và tình trạng tưới máu. Nếu nghi tổn thương mạch hoặc chèn ép khoang, giữ chi không cao hơn mức tim, báo bác sĩ ngay; không kê cao quá mức hoặc chỉ chờ đáp ứng thuốc giảm đau.

Hướng dẫn trẻ cử động các ngón chân nhẹ nhàng

Thực hiện y lệnh thuốc giảm đau

Trấn an, hỗ trợ tâm lý trẻ

4.3. Chăm sóc bột bó

Giữ bột khô, sạch

Không để trẻ:

Làm ướt bột

Nhét vật lạ vào bột

Tự ý đứng, đi khi chưa được phép

Kiểm tra mép bột, bảo vệ vùng tì đè

4.4. Vận động – sinh hoạt

Hướng dẫn:

Nằm, ngồi đúng tư thế

Tập vận động các khớp không bó bột

Sử dụng nạng, xe lăn (nếu được chỉ định)

Phòng ngừa ngã

4.5. Dinh dưỡng

Chế độ ăn đầy đủ năng lượng

Bảo đảm chất dinh dưỡng qua khẩu phần; chế phẩm bổ sung chỉ khi có chỉ định, phù hợp tuổi/bệnh nền:

Canxi

Vitamin D

Protein

Uống đủ nước, phòng táo bón khi bất động

4.6. Giáo dục sức khỏe cho gia đình

Hướng dẫn theo dõi tại nhà:

Đau tăng

Sưng nhiều, bột chật

Tím tái, lạnh, tê ngón chân

Nhắc tái khám đúng hẹn

Hướng dẫn chăm sóc sau tháo bột

5. Đánh giá

Tình trạng chi bó bột: tuần hoàn, cảm giác, vận động

Mức độ đau của trẻ

Tình trạng bột và da xung quanh

Sự hiểu biết và hợp tác của gia đình

Ghi chép hồ sơ điều dưỡng đầy đủ

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau vượt dự kiến hoặc tăng dù đã giảm đau, đau khi vận động thụ động phù hợp đánh giá, tê/yếu mới, chi căng hoặc tưới máu giảm: dừng thao tác, báo bác sĩ khẩn, đánh giá lại mạch–thần kinh. Mạch còn không loại trừ chèn ép khoang; không chờ đủ 5P. Giữ chi không cao hơn mức tim khi nghi giảm tưới máu; nới băng/bột chỉ do người được phép theo quy trình/chỉ định, ghi diễn biến.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

RCH Neurovascular observations: https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Neurovascular_observations/

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-04. QUY TRÌNH CHĂM SÓC SAU MỔ KẾT HỢP XƯƠNG CHI TRÊN Ở TRẺ EM

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Tuổi, giới

Nguyên nhân chấn thương: té ngã, tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông

Loại phẫu thuật:

Kết hợp xương bằng đinh Kirschner, nẹp vít, vis

Thời điểm mổ, thời gian hậu phẫu

Tiền sử:

Dị ứng thuốc, kháng sinh, thuốc giảm đau

Bệnh lý kèm theo: tim bẩm sinh, hen, rối loạn đông máu

Thuốc đang sử dụng theo y lệnh

1.2. Nhận định toàn trạng

Dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp

Tình trạng tri giác:

Tỉnh táo, quấy khóc, buồn ngủ

Mức độ đau (thang điểm phù hợp với lứa tuổi)

Tình trạng ăn uống, bài tiết

1.3. Nhận định chi phẫu thuật

Tuần hoàn:

Màu sắc, nhiệt độ bàn tay/ngón tay

Thời gian hồi máu mao mạch

Cảm giác:

Tê bì, giảm/mất cảm giác

Vận động:

Cử động các ngón tay

Phù nề:

Có/không, mức độ

Vết mổ:

Khô hay thấm dịch

Dấu hiệu nhiễm trùng: sưng, đỏ, nóng

Dẫn lưu (nếu có):

Số lượng, màu sắc dịch

Bột/nẹp cố định:

Khô, chắc, đúng tư thế

1.4. Cận lâm sàng (nếu có)

X-quang kiểm tra sau mổ

Công thức máu, CRP (theo chỉ định)

Các xét nghiệm khác nếu cần

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Chảy máu sau mổ

Nhiễm trùng vết mổ

Rối loạn tuần hoàn – thần kinh chi trên

Hội chứng chèn ép khoang

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Đau cấp sau phẫu thuật

Phù nề tăng

Hạn chế vận động chi trên

2.3. Nguy cơ liên quan

Trẻ hiếu động, va chạm vùng mổ

Gia đình thiếu kiến thức chăm sóc

Không tuân thủ tái khám và tập phục hồi chức năng

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chung

Đảm bảo an toàn sau phẫu thuật

Giảm đau, phòng ngừa biến chứng

Bảo vệ vết mổ và phương tiện kết hợp xương

Giúp trẻ phục hồi vận động phù hợp

Gia đình hiểu và phối hợp chăm sóc tốt

3.2. Mục tiêu cụ thể

Trẻ ổn định dấu hiệu sinh tồn

Vết mổ khô, không nhiễm trùng

Chi phẫu thuật hồng ấm, cử động được ngón tay

Trẻ giảm đau, hợp tác điều trị

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Theo dõi sau mổ

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn:

Theo dõi hồi tỉnh theo phương pháp vô cảm, mức an thần và chỉ định; ghi tri giác, đường thở, nhịp thở, SpO_2, mạch, huyết áp, đau và buồn nôn. Không lấy 30 phút–1 giờ/lần làm lịch chung an toàn cho mọi trẻ vừa gây mê.

Lịch chuyển sang theo dõi tại khoa theo bàn giao gây mê và tình trạng; tăng tần suất khi bất thường.

Theo dõi tuần hoàn, cảm giác, vận động và đau bằng thang phù hợp tuổi; ghi so sánh với ban đầu/chi lành. Sau bó bột, chấn thương hoặc mổ chi: kế hoạch theo dõi cá thể do bác sĩ/khoa xác nhận; tham khảo RCH ở trẻ em: mỗi giờ trong 24 giờ đầu, sau đó mỗi 4 giờ trong 48 giờ tiếp theo nếu ổn định, tăng tần suất khi bất thường. Không dùng lịch này thay theo dõi hồi tỉnh sau gây mê.

Báo bác sĩ ngay khi:

Đau tăng đột ngột

Tay tím tái, lạnh

Mất vận động/ngứa tê nhiều

4.2. Chăm sóc vết mổ và dẫn lưu

Giữ vết mổ khô, sạch

Thay băng vô khuẩn theo y lệnh

Theo dõi dịch dẫn lưu: Số lượng, màu sắc, tính chất dịch,…

Phát hiện sớm dấu hiệu nhiễm trùng

4.3. Giảm đau – tư thế

Thực hiện thuốc giảm đau theo y lệnh

Nâng đỡ chi theo chỉ định và tình trạng tưới máu. Nếu nghi tổn thương mạch hoặc chèn ép khoang, giữ chi không cao hơn mức tim, báo bác sĩ ngay; không kê cao quá mức hoặc chỉ chờ đáp ứng thuốc giảm đau.

Hướng dẫn trẻ cử động nhẹ nhàng các ngón tay

Trấn an, giảm lo lắng cho trẻ

4.4. Chăm sóc bột/nẹp cố định (nếu có)

Kiểm tra độ chặt, khô, sạch

Không để trẻ làm ướt hoặc va đập

Không tự ý tháo, chỉnh bột/nẹp

4.5. Dinh dưỡng – sinh hoạt

Cho trẻ ăn lại theo chỉ định

Chế độ ăn:

Giàu đạm

Canxi/vitamin D qua khẩu phần phù hợp; bổ sung chế phẩm theo chỉ định, không mặc định cho mọi trẻ.

Hướng dẫn sinh hoạt phù hợp, tránh vận động mạnh

4.6. Giáo dục sức khỏe cho gia đình

Hướng dẫn theo dõi tại nhà:

Sốt

Đau tăng

Sưng, đỏ vết mổ

Không để trẻ vận động mạnh chi mổ

Tuân thủ uống thuốc và tái khám đúng hẹn

Hướng dẫn tập phục hồi chức năng khi được chỉ định

5. Đánh giá

Dấu hiệu sinh tồn ổn định

Vết mổ tiến triển tốt

Không có biến chứng sau mổ

Trẻ giảm đau, vận động phù hợp

Gia đình hiểu và thực hiện đúng hướng dẫn

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau vượt dự kiến hoặc tăng dù đã giảm đau, đau khi vận động thụ động phù hợp đánh giá, tê/yếu mới, chi căng hoặc tưới máu giảm: dừng thao tác, báo bác sĩ khẩn, đánh giá lại mạch–thần kinh. Mạch còn không loại trừ chèn ép khoang; không chờ đủ 5P. Giữ chi không cao hơn mức tim khi nghi giảm tưới máu; nới băng/bột chỉ do người được phép theo quy trình/chỉ định, ghi diễn biến.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn

lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

RCH Neurovascular observations: https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Neurovascular_observations/

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-05. QUY TRÌNH CHĂM SÓC SAU MỔ KẾT HỢP XƯƠNG CHI DƯỚI Ở TRẺ EM

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Lý do nhập viện: chấn thương gãy xương chi dưới (đùi, cẳng chân, cổ chân…).

Thời điểm chấn thương, cơ chế chấn thương.

Phương pháp phẫu thuật: nẹp vít, đinh nội tuỷ, kim K, cố định ngoài.

Thời gian sau mổ.

Tiền sử bệnh lý: tim bẩm sinh, rối loạn đông máu, thiếu máu, suy dinh dưỡng.

Tiền sử dị ứng thuốc, kháng sinh, thuốc giảm đau.

1.2. Khám thực thể

a. Toàn thân

Dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

Mức độ tỉnh táo, phản xạ sau gây mê/gây tê.

Đánh giá đau theo thang FLACC hoặc Wong–Baker.

b. Chi phẫu thuật

Tình trạng băng mổ: khô/ướt, thấm máu/dịch.

Vết mổ: sưng, nóng, đỏ, đau.

Màu sắc da, nhiệt độ da, phù nề.

Đánh giá đau, cảm giác, vận động, màu/nhiệt độ, hồi máu mao mạch và mạch ngoại vi khi đánh giá được. Không chờ đủ 5P hoặc mất mạch để phát hiện chèn ép khoang; đau vượt dự kiến, đau khi kéo giãn thụ động và nhu cầu giảm đau tăng là dấu cảnh báo.

Tình trạng dụng cụ cố định: nẹp, bột, khung cố định ngoài.

1.3. Cận lâm sàng (nếu có)

Công thức máu sau mổ.

X-quang kiểm tra sau mổ.

Các xét nghiệm theo chỉ định bác sĩ.

1.4. Đánh giá các hệ thống

Hệ hô hấp (nguy cơ ứ đọng đờm sau gây mê).

Hệ tuần hoàn.

Hệ tiêu hoá (buồn nôn, chướng bụng sau mổ).

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Nguy cơ chảy máu sau mổ.

Nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, viêm xương.

Nguy cơ chèn ép khoang chi.

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Đau cấp liên quan đến can thiệp phẫu thuật.

Phù nề chi phẫu thuật.

Hạn chế vận động.

2.3. Nguy cơ liên quan trẻ em

Nguy cơ rối loạn tâm lý: lo lắng, sợ hãi.

Nguy cơ suy dinh dưỡng do bất động kéo dài.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chăm sóc chung

Đảm bảo an toàn sau mổ.

Giảm đau, giảm phù nề.

Phòng ngừa biến chứng.

Hỗ trợ phục hồi chức năng chi dưới.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Trẻ tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Vết mổ khô, không chảy máu, không nhiễm trùng.

Đau giảm đến mức chấp nhận được theo thang phù hợp tuổi, có mục tiêu cá thể và thời điểm đánh giá lại; không áp một ngưỡng cho mọi thang.

Chi phẫu thuật tuần hoàn tốt, không dấu hiệu chèn ép.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Theo dõi và chăm sóc sau mổ sớm

Theo dõi hồi tỉnh và sinh hiệu theo vô cảm/tình trạng; ghi kế hoạch cụ thể từ bàn giao. Theo dõi tuần hoàn, cảm giác, vận động và đau bằng thang phù hợp tuổi; ghi so sánh với ban đầu/chi lành. Sau bó bột, chấn thương hoặc mổ chi: kế hoạch theo dõi cá thể do bác sĩ/khoa xác nhận; tham khảo RCH ở trẻ em: mỗi giờ trong 24 giờ đầu, sau đó mỗi 4 giờ trong 48 giờ tiếp theo nếu ổn định, tăng tần suất khi bất thường. Không dùng lịch này thay theo dõi hồi tỉnh sau gây mê.

Theo dõi tình trạng chảy máu, dịch dẫn lưu (nếu có).

Nâng đỡ chi theo chỉ định và tình trạng tưới máu. Nếu nghi tổn thương mạch hoặc chèn ép khoang, giữ chi không cao hơn mức tim, báo bác sĩ ngay; không kê cao quá mức hoặc chỉ chờ đáp ứng thuốc giảm đau.

4.2. Chăm sóc vết mổ

Thay băng vô khuẩn theo y lệnh.

Quan sát dấu hiệu nhiễm trùng.

Giữ băng khô, sạch.

4.3. Giảm đau và phòng biến chứng

Đánh giá đau định kỳ.

Thực hiện thuốc giảm đau, kháng sinh theo y lệnh.

Theo dõi dấu hiệu chèn ép khoang.

4.4. Vận động và phục hồi chức năng

Hướng dẫn vận động các khớp không tổn thương.

Tập vận động thụ động/chủ động theo chỉ định.

Không cho trẻ chịu lực sớm lên chi mổ khi chưa được phép.

4.5. Chăm sóc dinh dưỡng – vệ sinh

Chế độ ăn giàu đạm, canxi, vitamin D.

Hỗ trợ vệ sinh cá nhân, phòng loét tì đè.

4.6. Giáo dục sức khoẻ

Hướng dẫn gia đình theo dõi bất thường.

Tư vấn chăm sóc trẻ tại nhà sau xuất viện.

Nhấn mạnh tuân thủ tái khám.

5. Đánh giá

Đánh giá đáp ứng điều trị hằng ngày.

So sánh mục tiêu và kết quả đạt được.

Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc khi cần

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau vượt dự kiến hoặc tăng dù đã giảm đau, đau khi vận động thụ động phù hợp đánh giá, tê/yếu mới, chi căng hoặc tưới máu giảm: dừng thao tác, báo bác sĩ khẩn, đánh giá lại mạch–thần kinh. Mạch còn không loại trừ chèn ép khoang; không chờ đủ 5P. Giữ chi không cao hơn mức tim khi nghi giảm tưới máu; nới băng/bột chỉ do người được phép theo quy trình/chỉ định, ghi diễn biến.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

RCH Neurovascular observations: https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Neurovascular_observations/

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-06. QUY TRÌNH CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG BỎNG NHIỆT

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Thời điểm bị bỏng: giờ, ngày xảy ra tai nạn

Nguyên nhân bỏng: nước sôi, lửa, kim loại nóng, dầu mỡ…

Thời gian tiếp xúc với tác nhân gây bỏng

Sơ cứu ban đầu: có làm mát vết bỏng không, bôi thuốc/dân gian gì không

Tiền sử bệnh lý:

Đái tháo đường

Tăng huyết áp

Tim mạch

Suy thận, suy gan

Tiền sử dị ứng: thuốc, băng gạc, dung dịch sát khuẩn

Tiền sử tiêm phòng uốn ván

1.2. Khám thực thể vết bỏng

Vị trí vết bỏng

Ước tính diện tích bằng phương pháp phù hợp tuổi; chỉ tính phần bỏng có tổn thương trung bì trở xuống vào TBSA dùng hồi sức. Không tính vùng chỉ đỏ da nông như bỏng sâu; bác sĩ xác nhận độ sâu/diện tích.

Độ sâu bỏng:

Bỏng độ I

Bỏng độ II (nông / sâu)

Bỏng độ III

Tình trạng vết thương:

Màu sắc da

Phỏng nước (bóng nước)

Hoại tử

Mức độ tiết dịch

Mùi bất thường

Dấu hiệu nhiễm trùng:

Đỏ, sưng, nóng, đau tăng

Mủ, sốt

1.3. Đánh giá toàn thân và các hệ thống

Dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở

Đánh giá đau (VAS hoặc thang điểm phù hợp)

Hệ hô hấp: khó thở (nếu bỏng diện rộng hoặc nghi ngờ hít khói)

Hệ tuần hoàn: dấu hiệu sốc bỏng

Hệ tiết niệu: lượng nước tiểu

Tình trạng tâm lý: lo lắng, sợ hãi, đau đớn

1.4. Cận lâm sàng (nếu có)

Công thức máu

CRP, bạch cầu

Đường huyết

Điện giải đồ

Cấy dịch vết thương (khi nghi nhiễm trùng)

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Nguy cơ nhiễm trùng vết bỏng

Nguy cơ sốc bỏng (với bỏng diện rộng)

Nguy cơ sẹo co kéo, hạn chế vận động

Nguy cơ rối loạn nước – điện giải

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Đau cấp tính liên quan đến tổn thương mô

Mất dịch qua vết bỏng

Sốt do phản ứng viêm hoặc nhiễm trùng

2.3. Nguy cơ liên quan bệnh nền

Chậm lành vết thương ở bệnh nhân:

Đái tháo đường

Suy giảm miễn dịch

Người cao tuổi

Nguy cơ biến chứng tim mạch khi đau, nhiễm trùng

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chăm sóc chung

Vết bỏng lành tốt, không nhiễm trùng

Người bệnh giảm đau, ổn định toàn thân

Phòng ngừa biến chứng và sẹo xấu

Người bệnh hiểu và tự chăm sóc đúng cách

3.2. Mục tiêu cụ thể

Giảm đau xuống mức chấp nhận được

Vết bỏng được che phủ và kiểm soát dịch/môi trường liền thương phù hợp loại băng, không có dấu nhiễm trùng; không cố làm khô mọi nền vết bỏng.

Dấu hiệu sinh tồn ổn định

Người bệnh tuân thủ điều trị và vệ sinh vết thương

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Chăm sóc vết bỏng

Vệ sinh tay, phòng hộ và kỹ thuật vô khuẩn khi thay băng theo quy trình; không mô tả toàn bộ môi trường là vô khuẩn tuyệt đối.

Rửa vết bỏng bằng:

NaCl 0,9%

Dung dịch sát khuẩn theo y lệnh

Xử lý bóng nước/cắt lọc theo chỉ định, bởi người đủ phạm vi/năng lực; không tự chọc mọi bóng nước.

Bôi thuốc:

Thuốc tại chỗ/băng do bác sĩ lựa chọn theo độ sâu, vị trí, tuổi và nguy cơ; không mặc định silver sulfadiazine cho mọi bỏng.

Thuốc mỡ kháng sinh theo y lệnh

Băng vết thương đúng kỹ thuật, không quá chặt

4.2. Giảm đau

Đánh giá đau trước – sau chăm sóc

Thực hiện thuốc giảm đau theo y lệnh

Hướng dẫn tư thế thoải mái, tránh tỳ đè

4.3. Dinh dưỡng

Chế độ ăn:

Giàu đạm (thịt, cá, trứng, sữa)

Dinh dưỡng và vi chất theo đánh giá thiếu/nguy cơ và chỉ định, không bổ sung liều cao thường quy.

Theo dõi dịch vào-ra và tưới máu; dịch uống/truyền theo diện tích bỏng và chỉ định cá thể, không coi uống nước đơn thuần đủ hồi sức bỏng rộng.

Theo dõi đường huyết (nếu có đái tháo đường)

4.4. Vệ sinh và chăm sóc toàn thân

Giữ da xung quanh vết bỏng sạch, khô

Thay quần áo, ga giường sạch

Phòng loét tỳ đè (nếu nằm lâu)

4.5. Giáo dục sức khỏe

Không tự ý bôi thuốc dân gian

Không làm vỡ bóng nước

Bảo vệ vết bỏng bằng băng phù hợp; giữ da quanh sạch và băng nguyên vẹn, không tự làm khô nền tổn thương.

Dấu hiệu cần tái khám ngay:

Sốt

Đau tăng

Mủ, mùi hôi

Hướng dẫn phòng ngừa tai nạn bỏng

5. Đánh giá

Vết bỏng:

Diện tích giảm

Không nhiễm trùng

Mức độ đau giảm

Người bệnh:

Sinh hiệu ổn định

Hợp tác điều trị tốt

Đánh giá lại kế hoạch chăm sóc, điều chỉnh khi cần

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Bỏng mới: dừng tiếp xúc tác nhân, làm mát vùng bỏng bằng nước mát chảy khi phù hợp, không dùng đá; giữ ấm phần cơ thể không bỏng, nhất là trẻ. Tránh trì hoãn hỗ trợ đường thở/tuần hoàn vì làm mát. Khàn/thở rít, khó thở sau hít khói, bỏng vòng

chi/ngực, tưới máu kém hoặc bỏng sâu/rộng/vị trí quan trọng cần bác sĩ đánh giá và chuyển chuyên khoa theo năng lực. Theo dõi dịch vào-ra, nhiệt độ và hồi sức theo y lệnh; không tự áp công thức dịch cho mọi tuổi.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

RCH Burns acute management: https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/burns/

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-07. QUY TRÌNH CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG BỎNG NHIỆT Ở TRẺ EM

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Thời điểm xảy ra bỏng, hoàn cảnh gây bỏng (nước sôi, thức ăn nóng, dầu mỡ, kim loại nóng…).

Thời gian từ khi bị bỏng đến khi nhập viện.

Sơ cứu ban đầu đã thực hiện (xả nước, bôi thuốc, đắp lá, kem…).

Tiền sử bệnh tật: suy dinh dưỡng, thiếu máu, bệnh bẩm sinh, bệnh da liễu.

Tiền sử dị ứng thuốc, dung dịch sát khuẩn.

Tình trạng tiêm chủng uốn ván.

1.2. Khám thực thể

a. Toàn thân

Dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, nhịp thở, huyết áp.

Dấu hiệu đau, quấy khóc, kích thích hoặc lơ mơ.

Đánh giá tình trạng mất nước, sốc (ở trẻ bỏng diện rộng).

b. Tại vết bỏng

Vị trí bỏng: mặt, cổ, thân mình, chi, vùng sinh dục.

Diện tích bỏng: ước tính theo bảng Lund–Browder (phù hợp cho trẻ em).

Độ sâu bỏng: bỏng độ I, II (nông/sâu), III.

Tình trạng vết bỏng:

Phỏng nước, trợt da, hoại tử.

Dịch tiết, mùi.

Dấu hiệu nhiễm trùng: đỏ, sưng, nóng, đau tăng, mủ.

Đánh giá mức độ đau theo thang FLACC hoặc Wong-Baker.

1.3. Cận lâm sàng (nếu có chỉ định)

Công thức máu.

CRP.

Điện giải đồ (bỏng diện rộng).

Cấy dịch vết bỏng khi nghi ngờ nhiễm trùng.

1.4. Đánh giá các hệ thống

Hệ hô hấp (đặc biệt nếu bỏng vùng mặt, cổ).

Hệ tuần hoàn.

Tình trạng dinh dưỡng và khả năng ăn uống.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Nguy cơ nhiễm trùng vết bỏng.

Nguy cơ sốc bỏng (ở trẻ bỏng diện rộng).

Nguy cơ sẹo co kéo, hạn chế vận động.

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Đau cấp liên quan đến tổn thương bỏng.

Mất nước, rối loạn điện giải.

Sốt do phản ứng viêm hoặc nhiễm trùng.

2.3. Nguy cơ liên quan đặc điểm trẻ em

Nguy cơ suy dinh dưỡng do tăng nhu cầu chuyển hoá.

Nguy cơ rối loạn tâm lý: sợ hãi, lo âu.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chăm sóc chung

Giảm đau và ổn định toàn trạng cho trẻ.

Phòng ngừa nhiễm trùng vết bỏng.

Thúc đẩy quá trình liền vết thương.

Hạn chế sẹo và di chứng chức năng.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Trẻ giảm đau, bớt quấy khóc.

Vết bỏng sạch, không có dấu hiệu nhiễm trùng.

Trẻ ăn uống được, không mất nước.

Gia đình hiểu và phối hợp chăm sóc trẻ.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Chăm sóc vết bỏng (theo chỉ định ngoại khoa)

Thực hiện thay băng vô khuẩn theo đúng quy trình Bộ Y tế.

Làm sạch vết bỏng bằng NaCl 0,9% hoặc dung dịch theo y lệnh.

Xử lý bóng nước theo kế hoạch bác sĩ và quy trình riêng, bởi người đủ phạm vi/năng lực; điều dưỡng không tự chích xả tất cả bóng nước.

Thuốc/băng điều trị theo y lệnh và tuổi, kiểm tra dị ứng/chống chỉ định; không mặc định bạc sulfadiazin hay thuốc mỡ cho mọi trẻ.

Theo dõi màu sắc, dịch tiết và dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.

4.2. Giảm đau và chăm sóc toàn thân (phối hợp bác sĩ ngoại khoa)

Đánh giá đau trước – trong – sau thay băng.

Thực hiện thuốc giảm đau theo y lệnh.

Giữ ấm cho trẻ, tránh hạ thân nhiệt.

4.3. Chăm sóc dinh dưỡng

Khuyến khích trẻ ăn sớm nếu không chống chỉ định.

Chế độ ăn giàu năng lượng, đạm, vitamin A, C, kẽm.

Theo dõi cân nặng và lượng ăn hằng ngày.

4.4. Vệ sinh – phòng nhiễm khuẩn

Rửa tay đúng quy trình trước và sau chăm sóc.

Dụng cụ chăm sóc riêng cho từng trẻ.

Thay băng khi bẩn, ướt.

4.5. Giáo dục sức khỏe cho gia đình

Hướng dẫn nhận biết dấu hiệu nhiễm trùng, biến chứng.

Hướng dẫn chăm sóc vết bỏng tại nhà.

Tư vấn phòng ngừa tai nạn bỏng cho trẻ.

5. Đánh giá

Đánh giá diễn tiến vết bỏng hằng ngày.

Đánh giá mức độ đau, khả năng ăn uống.

So sánh kết quả đạt được với mục tiêu đề ra.

Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc khi cần thiết.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Bỏng mới: dừng tiếp xúc tác nhân, làm mát vùng bỏng bằng nước mát chảy khi phù hợp, không dùng đá; giữ ấm phần cơ thể không bỏng, nhất là trẻ. Tránh trì hoãn hỗ trợ đường thở/tuần hoàn vì làm mát. Khàn/thở rít, khó thở sau hít khói, bỏng vòng chi/ngực, tưới máu kém hoặc bỏng sâu/rộng/vị trí quan trọng cần bác sĩ đánh giá và

chuyển chuyên khoa theo năng lực. Theo dõi dịch vào-ra, nhiệt độ và hồi sức theo y lệnh; không tự áp công thức dịch cho mọi tuổi.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

RCH Burns acute management: https://www.rch.org.au/clinicalguide/guideline_index/burns/

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-08. QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH LIỆT THẦN KINH QUAY MUỘN DO CHẤN THƯƠNG

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Chấn thương chi trên (đặc biệt gãy thân xương cánh tay).

Phương pháp điều trị trước đó: bó bột, kết hợp xương, phẫu thuật chỉnh hình.

Thời điểm xuất hiện liệt thần kinh quay (xuất hiện muộn sau chấn thương/mổ).

Diễn tiến triệu chứng: yếu tăng dần, mất vận động duỗi.

Bệnh lý kèm theo: đái tháo đường, bệnh thần kinh ngoại biên.

Tiền sử dị ứng thuốc.

1.2. Khám thực thể

Toàn thân: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

Chi tổn thương:

Vận động: giảm/mất duỗi cổ tay, ngón tay, ngón cái (bàn tay rũ).

Cảm giác: giảm/mất cảm giác vùng mu bàn tay, kẽ ngón I–II.

Tuần hoàn: màu sắc da, nhiệt độ, mạch ngoại vi.

Tình trạng vết mổ/bó bột (nếu có).

Tâm lý: lo âu, sợ mất chức năng chi.

1.3. Cận lâm sàng (theo y lệnh)

X-quang kiểm tra xương.

Điện cơ (EMG).

Siêu âm/MRI thần kinh khi cần.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

Giảm khả năng vận động chi trên liên quan đến tổn thương thần kinh quay.

Nguy cơ teo cơ và cứng khớp do bất động kéo dài.

Rối loạn cảm giác chi trên.

Lo âu liên quan đến hạn chế chức năng vận động.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chung

Bảo tồn và phục hồi tối đa chức năng chi trên.

Phòng ngừa biến chứng teo cơ, cứng khớp.

Nâng cao sự hợp tác điều trị của người bệnh.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Người bệnh duy trì tầm vận động khớp vai, khuỷu, cổ tay.

Không xuất hiện loét tì đè, teo cơ tiến triển.

Người bệnh hiểu và thực hiện đúng chương trình tập luyện.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Chăm sóc chi liệt

Nhận định vận động–cảm giác–tuần hoàn theo kế hoạch và ngay khi triệu chứng mới/tăng; liệt xuất hiện muộn sau mổ/bó bột cần báo bác sĩ sớm để tìm nguyên nhân chèn ép hoặc tổn thương khác.

Đặt tư thế chi đúng, tránh tì đè rãnh thần kinh quay.

Sử dụng nẹp cổ tay ở tư thế chức năng theo chỉ định.

4.2. Phục hồi chức năng

Tập theo giới hạn sau chấn thương/phẫu thuật và kế hoạch phục hồi chức năng, không kéo giãn quá mức hoặc tập qua vùng chưa được phép.

Tập duỗi cổ tay và ngón tay có hỗ trợ.

Phối hợp kỹ thuật viên phục hồi chức năng.

4.3. Thực hiện y lệnh

Thuốc theo y lệnh và nguyên nhân; vitamin nhóm B không mặc định là điều trị phục hồi thần kinh cho mọi trường hợp.

Theo dõi và phát hiện tác dụng không mong muốn của thuốc.

4.4. Chăm sóc tâm lý

Giải thích diễn biến và kế hoạch tái đánh giá; không cam kết hồi phục hoàn toàn.

Động viên, giảm lo âu cho người bệnh.

4.5. Giáo dục sức khỏe

Hướng dẫn tránh tư thế gây chèn ép thần kinh.

Hướng dẫn tập luyện và chăm sóc chi tại nhà.

Nhắc nhở tái khám, theo dõi điện cơ theo lịch.

5. Đánh giá

Đánh giá định kỳ vận động, cảm giác chi liệt.

Đánh giá mức độ hợp tác tập phục hồi chức năng.

Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc phù hợp.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau vượt dự kiến hoặc tăng dù đã giảm đau, đau khi vận động thụ động phù hợp đánh giá, tê/yếu mới, chi căng hoặc tưới máu giảm: dừng thao tác, báo bác sĩ khẩn, đánh giá lại mạch–thần kinh. Mạch còn không loại trừ chèn ép khoang; không chờ đủ 5P. Giữ chi không cao hơn mức tim khi nghi giảm tưới máu; nới băng/bột chỉ do người được phép theo quy trình/chỉ định, ghi diễn biến.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

RCH Neurovascular observations: https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Neurovascular_observations/

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-09. QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TỤ DỊCH DƯỚI DA SAU CHẤN THƯƠNG

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Thời điểm và cơ chế chấn thương (tai nạn sinh hoạt, lao động, giao thông, ngã đập…).

Thời gian xuất hiện khối tụ dịch sau chấn thương.

Diễn tiến khối tụ dịch: tăng nhanh/chậm, đau, căng tức, hạn chế vận động.

Các biện pháp đã điều trị: chườm lạnh, băng ép, chọc hút dịch, phẫu thuật dẫn lưu.

Tiền sử bệnh lý: rối loạn đông máu, đái tháo đường, bệnh gan, bệnh mạch máu.

Tiền sử dùng thuốc ảnh hưởng đông máu (kháng đông, kháng kết tập tiểu cầu).

Tiền sử dị ứng thuốc.

1.2. Khám thực thể

Toàn thân

Dấu hiệu sinh tồn: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở.

Tình trạng đau, sốt, mệt mỏi.

Tại vùng tụ dịch

Vị trí, kích thước, giới hạn khối tụ dịch.

Mức độ căng, đau khi sờ nắn.

Da phủ bên trên: bầm tím, đỏ, nóng, mỏng, nguy cơ hoại tử da.

Dấu hiệu nhiễm trùng: sưng nóng đỏ đau tăng, sốt, dịch mủ.

Tình trạng băng ép hoặc ống dẫn lưu (nếu có).

1.3. Cận lâm sàng (theo chỉ định)

Siêu âm mô mềm: xác định kích thước, mức độ và tính chất ổ tụ dịch.

Công thức máu (khi nghi nhiễm trùng).

Đông máu cơ bản (khi cần can thiệp chọc hút/phẫu thuật).

1.4. Khám các hệ thống cơ thể

Hệ vận động: mức độ hạn chế vận động vùng tổn thương.

Hệ tim mạch – hô hấp (đặc biệt ở người bệnh đa chấn thương).

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Nguy cơ nhiễm trùng ổ tụ dịch.

Nguy cơ hoại tử da vùng tụ dịch.

Nguy cơ tái tụ dịch sau chọc hút/dẫn lưu.

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Đau cấp hoặc kéo dài liên quan đến căng giãn mô mềm.

Hạn chế vận động vùng tổn thương.

Khó chịu, ảnh hưởng sinh hoạt.

2.3. Nguy cơ liên quan bệnh nền

Chậm hồi phục do đái tháo đường.

Tăng nguy cơ chảy máu, tái tụ dịch do rối loạn đông máu.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chăm sóc chung

Kiểm soát và làm giảm ổ tụ dịch.

Phòng ngừa biến chứng nhiễm trùng và hoại tử da.

Giảm đau, cải thiện vận động và sinh hoạt cho người bệnh.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Kích thước khối tụ dịch giảm dần.

Người bệnh giảm đau rõ rệt.

Không xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng.

Người bệnh hiểu và tuân thủ hướng dẫn chăm sóc.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Thực hiện mục tiêu chăm sóc

Theo dõi kích thước, mức độ căng đau ổ tụ dịch hằng ngày.

Đánh dấu ranh giới khối tụ (khi cần) để theo dõi tiến triển.

Băng ép theo y lệnh và kỹ thuật, theo dõi tưới máu/da và đau sau băng; không băng quá chặt hoặc ép ổ đang nghi nhiễm trùng khi chưa được bác sĩ đánh giá.

Chuẩn bị và hỗ trợ bác sĩ chọc hút dịch hoặc dẫn lưu khi có chỉ định.

Theo dõi dấu hiệu nhiễm trùng tại chỗ và toàn thân.

4.2. Chăm sóc dinh dưỡng

Hướng dẫn chế độ ăn đầy đủ năng lượng, giàu đạm.

Đánh giá dinh dưỡng, vitamin C/kẽm theo nhu cầu hoặc chỉ định, không bổ sung liều cao thường quy.

Kiểm soát đường huyết ở người bệnh đái tháo đường.

4.3. Vệ sinh – phòng nhiễm khuẩn

Giữ vùng tổn thương khô, sạch.

Rửa tay đúng quy trình trước và sau chăm sóc.

Thay băng khi bẩn, ướt hoặc theo y lệnh.

4.4. Giáo dục sức khoẻ

Hướng dẫn người bệnh nhận biết dấu hiệu bất thường: đau tăng, sưng nóng đỏ, sốt.

Hướng dẫn tuân thủ băng ép, hạn chế vận động vùng tổn thương.

Tư vấn tái khám đúng hẹn và phòng ngừa chấn thương tái diễn.

5. Đánh giá

Đánh giá hàng ngày kích thước và triệu chứng ổ tụ dịch.

Đánh giá mức độ giảm đau và cải thiện vận động.

So sánh kết quả đạt được với mục tiêu đề ra.

Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc khi cần thiết.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Khối tụ tăng nhanh, đau dữ dội, dấu giảm tưới máu, da đe dọa hoại tử hoặc sốt: báo bác sĩ ngay, đánh giá toàn thân; không tự chọc hút, xoa bóp hoặc siết băng ép. Theo dõi dẫn lưu đúng kế hoạch.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

RCH Neurovascular observations: https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Neurovascular_observations/

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-10. QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THOÁI HOÁ CỘT SỐNG

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Thời gian phát hiện bệnh, diễn tiến đau cột sống (đau cổ, lưng, thắt lưng).

Tính chất đau: âm ỉ, tăng khi vận động, giảm khi nghỉ ngơi.

Tiền sử chấn thương cột sống, lao động nặng, tư thế xấu kéo dài.

Các phương pháp đã điều trị: thuốc giảm đau, vật lý trị liệu, phẫu thuật (nếu có).

Tiền sử bệnh lý kèm theo: loãng xương, đái tháo đường, tăng huyết áp.

Tiền sử dùng thuốc kéo dài (corticoid, NSAIDs).

1.2. Khám thực thể

Toàn thân

Dấu hiệu sinh tồn.

Tình trạng đau, khả năng tự chăm sóc.

Tại cột sống

Vị trí đau, mức độ đau (thang điểm đau).

Hạn chế tầm vận động cột sống.

Biến dạng cột sống (gù, vẹo).

Co cứng cơ cạnh sống.

1.3. Đánh giá thần kinh

Tê bì, yếu chi, giảm cảm giác.

Phản xạ gân xương.

Dấu hiệu chèn ép rễ thần kinh.

1.4. Cận lâm sàng (theo chỉ định)

X-quang cột sống: gai xương, hẹp khe đĩa đệm.

CT/MRI khi nghi ngờ chèn ép thần kinh.

Đo mật độ xương khi nghi loãng xương.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Chèn ép rễ thần kinh, rối loạn vận động.

Hạn chế vận động kéo dài.

Thoát vị đĩa đệm kèm theo.

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Đau mạn tính vùng cột sống.

Cứng khớp buổi sáng.

Giảm khả năng lao động và sinh hoạt.

2.3. Nguy cơ liên quan bệnh nền

Loãng xương làm tăng nguy cơ gãy xương.

Bệnh mạn tính làm chậm hồi phục.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chăm sóc chung

Giảm đau và cải thiện chức năng vận động cột sống.

Phòng ngừa biến chứng và tiến triển nặng.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Người bệnh giảm đau rõ rệt.

Tăng tầm vận động cột sống.

Người bệnh tự thực hiện được các hoạt động sinh hoạt phù hợp.

Hiểu và tuân thủ hướng dẫn điều trị.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Thực hiện mục tiêu chăm sóc

Theo dõi và đánh giá mức độ đau hàng ngày.

Thực hiện thuốc giảm đau, kháng viêm theo y lệnh.

Hướng dẫn tư thế đúng khi nằm, ngồi, lao động.

Hỗ trợ và phối hợp thực hiện vật lý trị liệu.

4.2. Chăm sóc vận động – phục hồi chức năng

Hướng dẫn các bài tập vận động nhẹ nhàng phù hợp.

Khuyến khích vận động sớm, tránh nằm lâu.

Sử dụng dụng cụ hỗ trợ (đai lưng, nẹp cổ) khi có chỉ định.

4.3. Chăm sóc dinh dưỡng

Chế độ ăn giàu canxi, vitamin D, protein.

Kiểm soát cân nặng hợp lý.

4.4. Giáo dục sức khoẻ

Hướng dẫn thay đổi lối sống: tư thế lao động đúng, tránh mang vác nặng.

Tư vấn tuân thủ điều trị lâu dài.

Đau lưng kèm bí tiểu/rối loạn đại tiểu tiện mới, tê vùng yên ngựa hoặc yếu chi tăng cần báo và đánh giá khẩn, không chờ tái khám thường quy.

5. Đánh giá

Đánh giá mức độ giảm đau.

Đánh giá khả năng vận động và sinh hoạt.

So sánh kết quả đạt được với mục tiêu đề ra.

Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc khi cần.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Yếu chi tăng, bí tiểu/rối loạn đại tiểu tiện mới, tê vùng yên ngựa cần đánh giá khẩn; không chỉ cho tập hoặc chờ tái khám. Không tự kéo/nắn cột sống khi chưa có chỉ định và đánh giá an toàn.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

NICE NG127 Nhận diện dấu thần kinh cần chuyển khẩn: https://www.nice.org.uk/guidance/ng127/chapter/recommendations-for-adults-aged-over-16

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-11. QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TRẬT KHỚP

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Thời điểm và cơ chế chấn thương (ngã, tai nạn giao thông, lao động, thể thao).

Vị trí và mức độ đau.

Biến dạng chi, hạn chế vận động ngay sau chấn thương.

Tiền sử chấn thương hoặc phẫu thuật khớp trước đó.

Tiền sử bệnh lý kèm theo: loãng xương, bệnh khớp, rối loạn đông máu.

Tiền sử sử dụng thuốc chống đông, kháng viêm.

Tiền sử dị ứng thuốc.

1.2. Khám thực thể

Toàn thân

Dấu hiệu sinh tồn.

Đau, sưng, bầm tím tại vùng khớp tổn thương.

Tại khớp trật

Biến dạng khớp, sai trục, hạn chế vận động.

Tăng hoặc giảm cảm giác xung quanh khớp.

Tuần hoàn: màu sắc da, nhiệt độ, mạch ngoại vi.

Kiểm tra dấu hiệu thần kinh: cảm giác, vận động, phản xạ.

1.3. Cận lâm sàng (theo chỉ định)

X-quang khớp để xác định loại trật khớp, tổn thương kèm theo.

CT hoặc MRI khi cần đánh giá tổn thương dây chằng, sụn, mạch – thần kinh.

Xét nghiệm đông máu nếu dự kiến can thiệp phẫu thuật.

1.4. Khám các hệ thống cơ thể

Hệ vận động: khả năng vận động chi.

Hệ tuần hoàn: mạch, huyết áp.

Hệ thần kinh: cảm giác, phản xạ.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Nguy cơ tổn thương mạch máu và thần kinh.

Nguy cơ viêm khớp sau trật.

Nguy cơ teo cơ do bất động kéo dài.

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Đau cấp tính và hạn chế vận động.

Sưng nề, bầm tím.

Tê bì, dị cảm vùng chi.

2.3. Nguy cơ liên quan bệnh nền

Loãng xương, viêm khớp làm tăng nguy cơ trật khớp tái diễn.

Rối loạn đông máu làm tăng nguy cơ chảy máu.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chăm sóc chung

Ổn định khớp trật, giảm đau và phòng biến chứng.

Hỗ trợ phục hồi chức năng vận động.

Đảm bảo an toàn cho người bệnh.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Khớp được nắn đúng trục.

Người bệnh giảm đau, giảm sưng nề.

Phục hồi tầm vận động chi.

Người bệnh hiểu và tuân thủ hướng dẫn chăm sóc.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Thực hiện mục tiêu chăm sóc

Đánh giá và ghi mạch–thần kinh trước và sau nắn/bất động, khi đau hoặc cảm giác thay đổi; không chỉ kiểm tra sau trật khớp.

Cố định nâng đỡ ở tư thế an toàn, không tự nắn. Bác sĩ/người đủ phạm vi thực hiện nắn theo quy trình; điều dưỡng chuẩn bị, theo dõi gây tê/an thần và bàn giao.

Chườm lạnh khi phù hợp, có lớp ngăn và theo dõi da/cảm giác, từng đợt theo hướng dẫn; không đặt đá trực tiếp hoặc chườm liên tục 24 giờ.

Theo dõi tình trạng sưng, bầm tím.

Băng cố định, nẹp theo y lệnh.

4.2. Chăm sóc dinh dưỡng

Chế độ ăn giàu protein, vitamin C, canxi.

Hỗ trợ quá trình liền mô và phục hồi chức năng.

4.3. Vệ sinh – phòng nhiễm khuẩn

Giữ vùng khớp sạch, băng khô, thay băng đúng kỹ thuật.

Rửa tay trước và sau khi chăm sóc.

4.4. Giáo dục sức khỏe

Hướng dẫn người bệnh vận động chi an toàn theo y lệnh.

Tư vấn phòng ngừa trật khớp tái diễn.

Nhắc nhở tái khám đúng hẹn và tuân thủ chỉ định điều trị.

5. Đánh giá

Đánh giá vận động và cảm giác chi trật khớp sau nắn.

Đánh giá sưng, đau, tuần hoàn chi.

So sánh kết quả với mục tiêu chăm sóc.

Điều chỉnh kế hoạch khi cần.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Đau vượt dự kiến hoặc tăng dù đã giảm đau, đau khi vận động thụ động phù hợp đánh giá, tê/yếu mới, chi căng hoặc tưới máu giảm: dừng thao tác, báo bác sĩ khẩn, đánh giá lại mạch–thần kinh. Mạch còn không loại trừ chèn ép khoang; không chờ đủ 5P. Giữ chi không cao hơn mức tim khi nghi giảm tưới máu; nới băng/bột chỉ do người được phép theo quy trình/chỉ định, ghi diễn biến.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

RCH Neurovascular observations: https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Neurovascular_observations/

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-12. QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH HỘI CHỨNG ỐNG CỔ TAY

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Triệu chứng: tê bì, ngứa, đau hoặc yếu bàn tay, đặc biệt ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa.

Thời gian khởi phát triệu chứng, tiến triển.

Tiền sử bệnh lý kèm theo: tiểu đường, viêm khớp, béo phì, bệnh lý tuyến giáp.

Thói quen lao động: sử dụng bàn phím, công việc lặp lại cổ tay.

Tiền sử chấn thương cổ tay, phẫu thuật trước đó.

Tiền sử dị ứng thuốc.

1.2. Khám thực thể

Toàn thân

Dấu hiệu sinh tồn.

Đau, khó chịu trong sinh hoạt.

Tại cổ tay và bàn tay

Các nghiệm pháp chuyên biệt do người được đào tạo thực hiện, không cố làm gây đau nhiều; chẩn đoán do bác sĩ xác lập.

Kiểm tra vận động cổ tay và các ngón.

Đánh giá sức cơ và teo mô cái (thenar).

Kiểm tra cảm giác vùng 1/2 bàn tay ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa.

1.3. Cận lâm sàng (theo chỉ định)

Điện cơ (EMG) và dẫn truyền thần kinh: xác định mức độ tổn thương dây thần kinh giữa.

X-quang cổ tay: loại trừ tổn thương xương, khớp.

MRI cổ tay khi cần đánh giá tổn thương mô mềm.

1.4. Khám các hệ thống cơ thể

Hệ vận động: khả năng cầm nắm, nắm tay.

Hệ tuần hoàn: màu sắc, nhiệt độ chi.

Hệ thần kinh: cảm giác, phản xạ.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Nguy cơ teo cơ thenar và mất chức năng cầm nắm.

Nguy cơ tổn thương thần kinh giữa tại ống cổ tay kéo dài; đây là thần kinh ngoại biên, không phải thần kinh trung ương cổ tay.

Nguy cơ đau mạn tính và hạn chế vận động.

Nguy cơ nhiễm trùng, chảy máu hoặc phù nề sau phẫu thuật.

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Tê bì, đau, yếu tay.

Hạn chế vận động cổ tay và ngón.

Giảm khả năng thực hiện sinh hoạt hàng ngày.

2.3. Nguy cơ liên quan bệnh nền

Tiểu đường, viêm khớp, béo phì làm tăng nguy cơ tiến triển và khó hồi phục.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chăm sóc chung

Giảm triệu chứng đau và tê bì.

Ngăn ngừa teo cơ và biến dạng tay.

Phục hồi chức năng vận động và cầm nắm.

Đảm bảo an toàn trong chăm sóc trước và sau phẫu thuật.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Giảm đau và tê bì rõ rệt.

Người bệnh duy trì vận động cổ tay và ngón tay.

Phòng ngừa teo cơ thenar.

Người bệnh hiểu và tuân thủ hướng dẫn điều trị, tập luyện và chăm sóc sau phẫu thuật.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Trước phẫu thuật

Chuẩn bị người bệnh: nhịn ăn uống theo y lệnh, làm xét nghiệm tiền phẫu.

Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, tình trạng sức khỏe toàn thân.

Giáo dục người bệnh và gia đình về quá trình phẫu thuật và chăm sóc sau mổ.

Kiểm tra bác sĩ đã giải thích và người bệnh/người đại diện hợp pháp đồng ý đúng quy định; điều dưỡng không chỉ yêu cầu ký khi chưa được giải thích.

4.2. Sau phẫu thuật

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, vết mổ, tình trạng phù nề, chảy máu.

Theo dõi triệu chứng đau và tê bì.

Bảo vệ vết mổ, thay băng đúng kỹ thuật.

Nẹp/bất động theo chỉ định cụ thể; không mặc định mọi người sau giải phóng ống cổ tay cần nẹp thường quy.

Hướng dẫn người bệnh vận động nhẹ, phù hợp và an toàn.

4.3. Chăm sóc vận động – phục hồi chức năng

Hướng dẫn bài tập vận động cổ tay và ngón tay nhẹ nhàng sau khi bác sĩ cho phép.

Theo dõi tiến triển sức cơ và vận động.

Ngăn ngừa cứng khớp, teo cơ.

4.4. Chăm sóc dinh dưỡng

Chế độ ăn đầy đủ năng lượng, giàu vitamin và khoáng chất.

Kiểm soát bệnh nền (tiểu đường, béo phì) để tăng hiệu quả hồi phục.

4.5. Giáo dục sức khỏe

Hướng dẫn tư thế lao động đúng, nghỉ ngơi, tránh lặp lại cổ tay quá mức.

Nhận biết các dấu hiệu cần tái khám: đau tăng, tê bì kéo dài, yếu tay, sưng đỏ hoặc chảy máu vết mổ.

Tuân thủ tập luyện và sử dụng nẹp (nếu có).

5. Đánh giá

Đánh giá triệu chứng tê bì, đau, sức cơ, vận động hàng ngày.

Đánh giá tình trạng vết mổ, phù nề, tuần hoàn chi.

Đánh giá khả năng thực hiện sinh hoạt hàng ngày.

So sánh kết quả với mục tiêu đề ra.

Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc khi cần.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Khó thở, giảm ý thức, chảy máu nhiều, dấu giảm tưới máu, đau vượt dự kiến, sốt kèm xấu đi hoặc yếu/tê mới: báo bác sĩ, đánh giá và hỗ trợ cấp cứu theo tình trạng. Không chỉ tăng thuốc giảm đau để che dấu diễn biến.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

AAOS Management of Carpal Tunnel Syndrome 2024: https://www.aaos.org/globalassets/quality-and-practice-resources/carpal-tunnel/carpal-tunnel-2024/cts-cpg.pdf

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-13. QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NGÓN TAY CÒ SÚNG

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Thời gian và mức độ xuất hiện triệu chứng: đau, căng cứng, tiếng kêu “cò súng” khi co duỗi ngón tay.

Ngón tay bị ảnh hưởng, số lượng ngón, thời gian mắc bệnh.

Tiền sử bệnh lý kèm theo: tiểu đường, viêm khớp, béo phì.

Tiền sử chấn thương ngón tay hoặc phẫu thuật trước đó.

Thói quen lao động: gõ bàn phím, công việc lặp lại động tác co duỗi ngón tay.

Tiền sử dị ứng thuốc.

1.2. Khám thực thể

Khớp ngón tay: sưng nề, đau khi ấn gân gấp.

Kiểm tra khả năng co duỗi ngón tay.

Nghe và ghi nhận hiện tượng “cò súng” khi vận động.

Đánh giá sức cơ và cảm giác ngón tay.

Kiểm tra tuần hoàn: màu sắc, nhiệt độ đầu ngón.

1.3. Cận lâm sàng (theo chỉ định)

Siêu âm mô mềm ngón tay để đánh giá gân và bao gân.

X-quang ngón tay nếu nghi ngờ tổn thương xương hoặc khớp đi kèm.

Xét nghiệm tiền phẫu: công thức máu, đông máu, sinh hóa cơ bản.

1.4. Khám các hệ thống cơ thể

Hệ vận động: khả năng vận động tay và cầm nắm.

Hệ tuần hoàn: mạch, huyết áp.

Hệ thần kinh: cảm giác và phản xạ tay.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Nguy cơ teo cơ và cứng khớp ngón tay.

Nguy cơ nhiễm trùng, chảy máu sau phẫu thuật.

Nguy cơ đau mạn tính và hạn chế vận động.

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Đau, sưng, “cò súng” khi co duỗi ngón tay.

Hạn chế vận động và khả năng cầm nắm.

2.3. Nguy cơ liên quan bệnh nền

Tiểu đường, viêm khớp, béo phì làm tăng nguy cơ biến chứng và khó hồi phục.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chăm sóc chung

Giảm triệu chứng đau và căng cứng.

Phục hồi vận động ngón tay và chức năng cầm nắm.

Đảm bảo an toàn và phòng ngừa biến chứng trước và sau phẫu thuật.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Ngón tay có thể co duỗi bình thường sau phẫu thuật.

Người bệnh giảm đau, giảm sưng nề.

Phòng ngừa nhiễm trùng và teo cơ.

Người bệnh và gia đình hiểu hướng dẫn chăm sóc và tập luyện sau mổ.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Trước phẫu thuật

Chỉ chuẩn bị tiền phẫu khi đã có chỉ định mổ; nhịn ăn theo phương pháp vô cảm và y lệnh, kiểm tra hồ sơ/đồng ý hợp lệ. Điều trị bảo tồn hoặc tiêm theo bác sĩ, không mặc định mọi ngón tay cò súng cần mổ.

Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn, tình trạng sức khỏe tổng thể.

Giáo dục người bệnh và gia đình về quá trình phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu và tập luyện.

4.2. Sau phẫu thuật

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, tình trạng vết mổ, sưng nề, chảy máu.

Theo dõi triệu chứng đau, tê hoặc khó vận động ngón tay.

Thay băng, giữ vết mổ khô sạch, sử dụng nẹp ngón tay theo y lệnh.

Hướng dẫn người bệnh vận động nhẹ, tránh tác động mạnh vào ngón tay.

4.3. Chăm sóc vận động – phục hồi chức năng

Hướng dẫn bài tập co duỗi ngón tay nhẹ nhàng sau khi bác sĩ cho phép.

Theo dõi tiến triển vận động và sức cơ.

Ngăn ngừa cứng khớp, teo cơ và hạn chế vận động.

4.4. Chăm sóc dinh dưỡng

Chế độ ăn đầy đủ năng lượng, giàu vitamin và khoáng chất.

Kiểm soát bệnh nền (tiểu đường, béo phì) để tăng hiệu quả hồi phục.

4.5. Giáo dục sức khỏe

Hướng dẫn tránh lặp lại động tác co duỗi quá mức trong sinh hoạt và lao động.

Nhận biết các dấu hiệu cần tái khám: đau tăng, sưng đỏ, chảy máu vết mổ, hạn chế vận động.

Tuân thủ tập luyện và sử dụng nẹp theo hướng dẫn.

5. Đánh giá

Đánh giá triệu chứng đau, sưng, khả năng vận động ngón tay.

Theo dõi vết mổ, tuần hoàn và tình trạng phù nề.

So sánh kết quả đạt được với mục tiêu chăm sóc.

Điều chỉnh kế hoạch chăm sóc khi cần.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

Khó thở, giảm ý thức, chảy máu nhiều, dấu giảm tưới máu, đau vượt dự kiến, sốt kèm xấu đi hoặc yếu/tê mới: báo bác sĩ, đánh giá và hỗ trợ cấp cứu theo tình trạng. Không chỉ tăng thuốc giảm đau để che dấu diễn biến.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-14. QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CHẤN ĐỘNG NÃO DO CHẤN THƯƠNG

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Thời điểm và cơ chế chấn thương (tai nạn giao thông, té ngã, tai nạn sinh hoạt, lao động…).

Có hay không mất ý thức sau chấn thương, thời gian mất ý thức (nếu có).

Triệu chứng sau chấn thương: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn, choáng váng, lú lẫn.

Tiền sử chấn thương sọ não trước đó.

Tiền sử bệnh lý: tăng huyết áp, rối loạn đông máu, động kinh.

Tiền sử sử dụng rượu bia, chất kích thích hoặc thuốc an thần.

Tiền sử dị ứng thuốc.

1.2. Khám thực thể

Toàn thân

Dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ.

Tình trạng ý thức: tỉnh táo, lơ mơ, kích thích.

Thần kinh

Đánh giá tri giác theo thang điểm Glasgow (GCS).

Đánh giá đồng tử: kích thước, phản xạ ánh sáng.

Khả năng định hướng không gian – thời gian – bản thân.

Rối loạn trí nhớ ngắn hạn.

Khám đầu – mặt – cổ

Vết thương da đầu, bầm tím, sưng nề.

Dấu hiệu gãy nền sọ: chảy máu tai, mũi, bầm quanh mắt.

1.3. Cận lâm sàng (theo chỉ định)

CT sọ não theo tiêu chí/chỉ định bác sĩ và nguy cơ; không chụp thường quy mọi chấn động não. Ghi thuốc chống đông/kháng kết tập tiểu cầu và tổn thương phối hợp.

Công thức máu, đông máu khi cần.

1.4. Khám các hệ thống cơ thể

Hô hấp: nhịp thở, SpO_2.

Tim mạch: mạch, huyết áp.

Hệ vận động: yếu liệt chi, rối loạn phối hợp.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Nguy cơ xuất huyết não muộn.

Nguy cơ phù não, tăng áp lực nội sọ.

Nguy cơ co giật sau chấn thương.

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Đau đầu cấp và kéo dài.

Buồn nôn, nôn.

Rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ.

2.3. Nguy cơ liên quan bệnh nền

Người cao tuổi hoặc có rối loạn đông máu dễ biến chứng nặng.

Người bệnh nghiện rượu, dùng thuốc an thần.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chăm sóc chung

Theo dõi và phát hiện sớm các dấu hiệu biến chứng thần kinh.

Giảm triệu chứng khó chịu cho người bệnh.

Đảm bảo an toàn và phục hồi tri giác ổn định.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Duy trì/cải thiện tri giác so với ban đầu; mọi giảm GCS cần đánh giá, không coi GCS ≥14 mặc định là mục tiêu ổn định để cho về.

Không xuất hiện dấu hiệu thần kinh khu trú.

Giảm đau đầu, buồn nôn.

Người bệnh và gia đình hiểu hướng dẫn theo dõi.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Thực hiện mục tiêu chăm sóc

Theo dõi và ghi GCS từng thành phần, đồng tử, vận động chi, mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ và SpO_2. Với người nhập viện theo dõi chấn thương đầu, tham khảo NICE NG232: mỗi 30 phút đến GCS 15; khi GCS 15 theo dõi mỗi 30 phút trong 2 giờ, mỗi giờ trong 4 giờ, sau đó mỗi 2 giờ nếu ổn định. Khi xấu đi, đánh giá khẩn và tăng tần suất; kế hoạch chuyên khoa/hồi sức sau mổ có thể chặt hơn.

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, SpO_2.

Đánh giá đồng tử định kỳ.

Nghỉ tương đối giai đoạn đầu, tăng hoạt động theo dung nạp và hướng dẫn; không nghỉ tuyệt đối kéo dài cho mọi chấn động não. Tư thế theo huyết động và tổn thương cột sống cổ phối hợp, không kê đầu cao mặc định mọi trường hợp.

Thực hiện thuốc giảm đau, chống nôn theo y lệnh.

4.2. Chăm sóc an toàn

Đảm bảo môi trường yên tĩnh, ánh sáng phù hợp.

Phòng ngừa té ngã.

Khi co giật: bảo vệ khỏi va chạm, không ghì giữ hoặc nhét vật vào miệng; ghi thời gian, đánh giá đường thở/hô hấp, gọi hỗ trợ và thuốc theo phác đồ/y lệnh.

4.3. Chăm sóc dinh dưỡng

Ăn uống khi tỉnh đủ, nuốt an toàn và không có chống chỉ định/cần can thiệp theo bác sĩ; không chỉ dựa vẻ tỉnh táo.

Chia nhỏ bữa, tránh ăn quá no.

4.4. Giáo dục sức khoẻ

Hướng dẫn người bệnh và gia đình theo dõi tại nhà: đau đầu tăng, nôn nhiều, lơ mơ, co giật.

Trở lại học/làm việc và hoạt động từng bước theo triệu chứng; tránh thể thao va chạm/nguy cơ chấn thương lại đến khi được phép.

Tái khám đúng hẹn.

5. Đánh giá

Đánh giá GCS, đồng tử, vận động chi và sinh hiệu theo từng mốc theo dõi đã xác định, không chỉ hằng ngày.

Đánh giá hiệu quả giảm đau, chống nôn.

So sánh kết quả đạt được với mục tiêu đề ra.

Ghi nhận và báo bác sĩ khi có bất thường.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

GCS giảm, đồng tử bất thường mới, yếu chi mới, co giật, đau đầu tăng hoặc nôn lặp: gọi bác sĩ/cấp cứu, đánh giá ABCDE và bảo vệ cột sống cổ khi nghi tổn

thương. Không cho ăn/uống khi giảm ý thức hoặc chưa an toàn. Không quy giảm tri giác cho rượu/an thần khi chưa loại trừ tổn thương. Nếu co giật, không nhét vật vào miệng; ghi thời gian và hỗ trợ theo phác đồ.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Xuất viện do bác sĩ quyết định sau đánh giá; bố trí người có trách nhiệm theo dõi theo kế hoạch, đặc biệt 24 giờ đầu sau chấn thương đầu. Cung cấp hướng dẫn bằng văn bản, không tự lái xe hoặc trở lại hoạt động nguy cơ khi chưa được phép.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

NICE NG232 Head injury: https://www.nice.org.uk/guidance/NG232/chapter/recommendations

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

CS-NCT-15. QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO CÓ TỔN THƯƠNG Ổ NÃO

Mã đề xuất, phiên bản trình thẩm định 1.0; đơn vị thực hiện theo tổ chức và danh mục được phép của bệnh viện.

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh; ghi tình trạng ban đầu, bệnh nền/thuốc/dị ứng, nhận định ABCDE theo nguy cơ. Các xét nghiệm trong danh mục thực hiện khi bác sĩ chỉ định. Thang đau, sinh hiệu và đánh giá thần kinh phù hợp tuổi/khả năng giao tiếp; không suy chẩn đoán chỉ từ một chỉ số.

1.1. Khai thác tiền sử

Cơ chế chấn thương (tai nạn giao thông, té ngã, tai nạn lao động, bạo lực).

Thời gian và mức độ mất ý thức.

Triệu chứng ngay sau chấn thương: đau đầu, nôn, co giật, lú lẫn.

Tiền sử bệnh lý: tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn đông máu.

Tiền sử chấn thương sọ não hoặc phẫu thuật sọ não.

Tiền sử dị ứng thuốc.

1.2. Khám thực thể

Toàn thân

Dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ.

Tri giác: tỉnh, lơ mơ, hôn mê.

Thần kinh

Đánh giá tri giác theo thang điểm Glasgow (GCS).

Kiểm tra đồng tử: kích thước, phản xạ ánh sáng.

Đánh giá rối loạn vận động và cảm giác chi.

Phát hiện dấu hiệu thần kinh khu trú (yếu chi, liệt nửa người).

Khám đầu – mặt – cổ

Vết thương, sưng nề, bầm tím.

Dấu hiệu gãy nền sọ: chảy máu tai, mũi, bầm quanh mắt.

1.3. Cận lâm sàng

CT/MRI sọ não: xác định vị trí, kích thước và mức độ tổn thương ổ não.

Công thức máu, đông máu, sinh hóa cơ bản.

Xét nghiệm khác theo chỉ định (CRP, điện giải…)

1.4. Khám các hệ thống cơ thể

Hô hấp: nhịp thở, SpO_2.

Tim mạch: mạch, huyết áp.

Hệ vận động: tầm vận động chi, dấu hiệu liệt.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

Chọn vấn đề hiện có/nguy cơ theo dữ liệu người bệnh, ghi căn cứ; không mặc định tất cả mục gợi ý là chẩn đoán của mọi người bệnh. Biến chứng y khoa là nội dung cần phát hiện và phối hợp xử trí.

2.1. Nguy cơ biến chứng

Tăng áp lực nội sọ.

Xuất huyết não muộn, phù não.

Co giật sau chấn thương.

Nhiễm trùng sau phẫu thuật.

Rối loạn tuần hoàn – hô hấp.

2.2. Nguy cơ triệu chứng

Đau đầu dữ dội.

Buồn nôn, nôn.

Giảm tri giác, lú lẫn.

Yếu liệt chi, rối loạn cảm giác.

2.3. Nguy cơ liên quan bệnh nền

Cao tuổi, rối loạn đông máu, tiểu đường.

Bệnh tim mạch, hô hấp làm tăng nguy cơ biến chứng.

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Cá thể hóa mục tiêu có thời điểm đánh giá, mức đau chấp nhận được, chức năng/tưới máu và nhu cầu ăn uống. Ghi tần suất theo dõi, người phụ trách và điều kiện báo bác sĩ; tăng theo dõi khi thay đổi, không chờ lượt kế tiếp.

3.1. Mục tiêu chăm sóc chung

Theo dõi sát tri giác và chức năng thần kinh.

Ngăn ngừa biến chứng nội sọ và nhiễm trùng.

Giảm triệu chứng đau, nôn.

Đảm bảo an toàn và hỗ trợ hồi phục.

3.2. Mục tiêu cụ thể

GCS ổn định hoặc cải thiện theo tiến triển.

Không xuất hiện dấu hiệu thần kinh khu trú mới.

Giảm đau đầu, buồn nôn.

Người bệnh và gia đình hiểu hướng dẫn theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật.

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Trước phẫu thuật

Chuẩn bị trước mổ chỉ khi có chỉ định; bảo đảm hỗ trợ cấp cứu, xét nghiệm và đồng ý theo quy định, không trì hoãn xử trí nguy kịch để hoàn tất hành chính.

Đánh giá dấu hiệu sinh tồn và tri giác.

Giáo dục người bệnh và gia đình về phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu.

4.2. Sau phẫu thuật

Theo dõi và ghi GCS từng thành phần, đồng tử, vận động chi, mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ và SpO_2. Với người nhập viện theo dõi chấn thương đầu, tham khảo NICE NG232: mỗi 30 phút đến GCS 15; khi GCS 15 theo dõi mỗi 30 phút trong 2 giờ, mỗi giờ trong 4 giờ, sau đó mỗi 2 giờ nếu ổn định. Khi xấu đi, đánh giá khẩn và tăng tần suất; kế hoạch chuyên khoa/hồi sức sau mổ có thể chặt hơn.

Theo dõi dấu hiệu sinh tồn, tuần hoàn, hô hấp.

Theo dõi vết mổ, dấu hiệu nhiễm trùng, chảy máu.

Kiểm soát đau, chống nôn theo y lệnh.

Tư thế đầu/cổ trung tính và nâng đầu theo chỉ định khi huyết động cho phép, có xét tổn thương cột sống cổ; không ép mạch cổ hoặc tự thay phương án hồi sức.

4.3. Chăm sóc vận động – phục hồi chức năng

Hỗ trợ vận động sớm chi trên – dưới nếu được phép.

Ngăn ngừa teo cơ và cứng khớp.

Phối hợp vật lý trị liệu theo y lệnh.

4.4. Chăm sóc dinh dưỡng

Đánh giá nuốt và nhu cầu dinh dưỡng, cho ăn qua đường phù hợp theo bác sĩ khi an toàn; phòng sặc, không cho ăn uống miệng khi chưa đánh giá.

Kiểm soát bệnh nền (tiểu đường, tim mạch) để hỗ trợ hồi phục.

4.5. Giáo dục sức khỏe

Hướng dẫn gia đình nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm: đau tăng, nôn nhiều, lú lẫn, yếu liệt chi mới.

Tuân thủ lịch tái khám và chăm sóc tại nhà.

Giữ môi trường yên tĩnh, an toàn.

5. Đánh giá

Đánh giá thần kinh và sinh hiệu theo từng mốc trong kế hoạch chuyên khoa, không thay bằng một lần hằng ngày.

Đánh giá vết mổ, tuần hoàn, hô hấp.

So sánh kết quả đạt được với mục tiêu chăm sóc.

Điều chỉnh kế hoạch khi cần.

Dấu cần báo ngay và hành động ưu tiên

GCS giảm, đồng tử bất thường mới, yếu chi mới, co giật, đau đầu tăng hoặc nôn lặp: gọi bác sĩ/cấp cứu, đánh giá ABCDE và bảo vệ cột sống cổ khi nghi tổn thương. Không cho ăn/uống khi giảm ý thức hoặc chưa an toàn. Không quy giảm tri giác cho rượu/an thần khi chưa loại trừ tổn thương. Nếu co giật, không nhét vật vào miệng; ghi thời gian và hỗ trợ theo phác đồ.

Ghi hồ sơ bàn giao và hướng dẫn về nhà

Ghi thời điểm, nhận định, vấn đề/mục tiêu, thuốc/can thiệp và đáp ứng; bàn giao ISBAR gồm chẩn đoán, phẫu thuật/vô cảm, bất động, mạch–thần kinh hoặc GCS, dẫn lưu, y lệnh và kế hoạch nhận định lại. Bên nhận xác nhận tiếp nhận. Hướng dẫn lịch hẹn cụ thể, chăm sóc/vận động theo chỉ định và dấu cần khám ngay; yêu cầu người bệnh/người chăm sóc nhắc lại.

Xuất viện do bác sĩ quyết định sau đánh giá; bố trí người có trách nhiệm theo dõi theo kế hoạch, đặc biệt 24 giờ đầu sau chấn thương đầu. Cung cấp hướng dẫn bằng văn bản, không tự lái xe hoặc trở lại hoạt động nguy cơ khi chưa được phép.

Nguồn đối chiếu

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . Bản nguồn QTCS NGOẠI CT 2025 CẬP NHẬT do bệnh viện cung cấp.

NICE NG232 Head injury: https://www.nice.org.uk/guidance/NG232/chapter/recommendations

Đơn vị chuyên môn xác nhận trước ban hành: phạm vi kỹ thuật, hướng dẫn điều trị tại bệnh viện, tần suất theo dõi theo tuổi/nguy cơ, phương tiện và đường gọi hỗ trợ. Tài liệu tham khảo chưa rõ số hiệu trong nguồn cần bổ sung bản gốc nếu sử dụng làm căn cứ chính thức.

Phiếu ghi nhận và đánh giá chăm sóc

Họ tên/ngày sinh/mã người bệnh: …… Ngày giờ: ……

Nhận định và giá trị ban đầu: ……

Vấn đề điều dưỡng và căn cứ: ……

Mục tiêu/thời điểm đánh giá, tần suất theo dõi: ……

Can thiệp/thuốc theo y lệnh, người thực hiện và thời gian: ……

Đáp ứng/giá trị sau, nội dung báo bác sĩ và thời gian: ……

Bàn giao/nơi và người nhận, kế hoạch tiếp theo: ……

Hướng dẫn về nhà/lịch tái khám và xác nhận nhắc lại: ……

Tóm tắt hiệu chỉnh và xác nhận

Giữ 15 quy trình và cấu trúc chăm sóc 5 bước; sửa trực tiếp 58 đoạn về lịch theo dõi, tư thế, phạm vi can thiệp, thuốc/dinh dưỡng và nhận diện nguy cơ. Bổ sung bàn giao và căn cứ có đường dẫn; không tự coi các nguồn dẫn chung chưa rõ số hiệu là đã xác minh. File gốc giữ nguyên.

Người biên soạn: …… Thẩm định chuyên môn: …… Phê duyệt: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……